KIT 10 – INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC) / PACIENTE RENAL CRÔNICO DESCOMPENSADO

Referências: ABRAMEDE 2024 • KDIGO 2023 • SBN • Ministério da Saúde – Protocolo Clínico de Doença Renal Crônica

---

Objetivo

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem nos pacientes com **insuficiência renal crônica (IRC)** ou **descompensação aguda sobre crônica**, visando avaliação da gravidade, causas reversíveis e necessidade de terapia renal substitutiva (TRS).

---

1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA

- Identificar **estágio da doença renal crônica** (segundo taxa de filtração glomerular – TFG).
- Avaliar **sintomas de descompensação**: dispneia, edema, confusão mental, náusea, vômito, oligúria, anúria, arritmias ou sinais de uremia.
- Investigar **fatores precipitantes:** infecção, desidratação, uso de contraste, drogas nefrotóxicas, obstrução urinária, descompensação cardíaca.
- Avaliar **presença de cateter venoso central, fístula ou enxerto arteriovenoso.**

---

2. EXAMES LABORATORIAIS

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Ureia / Creatinina	Todos os pacientes com IRC ou suspeita de descompensação.	—
Eletrólitos (Na, K)	Monitorização de distúrbios eletrolíticos, hipercalemia e acidose.	Casos estáveis em diálise regular sem intercorrência.
Gasometria arterial / venosa + Lactato	Avaliar acidose metabólica, hipercapnia, descompensação respiratória.	Pacientes compensados e assintomáticos.
Hemograma completo	Avaliação de anemia da IRC, infecção e plaquetopenia.	—
PCR / Procalcitonina	Suspeita de infecção (sepse, pneumonia, ITU, foco abdominal).	Casos estáveis sem febre.

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Glicemia capilar / sérica	Avaliar diabetes como fator agravante.	—
TGO / TGP / FA / GGT / Bilirrubinas	Avaliar função hepática e toxicidade medicamentosa.	Casos puramente renais sem comorbidades hepáticas.
EAS (Urina tipo I)	Identificar proteinúria, hematúria, infecção.	Pacientes anúricos.
Urocultura / Hemocultura	Suspeita de infecção sistêmica ou urinária.	Casos sem febre ou leucocitose.
Troponina / CK-MB	Pacientes com dispneia, dor torácica, IC descompensada.	Sem sintomas cardiovasculares.

3. EXAMES DE IMAGEM

Exame	Indicação	Evitar / Não Indicado
USG de rins e vias urinárias	Avaliar tamanho renal, simetria, espessura cortical, dilatação pielocalicial, obstrução.	Pacientes já dialíticos com achados prévios conhecidos.
USG abdominal total (POCUS)	Avaliar ascite, congestão hepática, derrame pleural, bexiga repleta ou obstrução.	Casos com diagnóstico de IRC terminal e sem complicações.
RX de Tórax (PA/AP)	Suspeita de congestão pulmonar, edema agudo, sobrecarga volêmica.	Casos sem dispneia ou congestão clínica.
ECG de 12 derivações	Avaliar arritmias, distúrbios do potássio, sinais de sobrecarga ventricular.	—
TC de abdome / pelve (sem contraste)	Suspeita de obstrução, litíase, abscesso, infecção renal.	Casos estáveis, sem dor ou febre.

4. CRITÉRIOS DE GRAVIDADE E INDICAÇÃO DE TRS (HEMODIÁLISE URGENTE)

Critério	Achado Laboratorial / Clínico
A – Acidose metabólica refratária	pH < 7,1 ou HCO_3^- < 10 mEq/L
E – Eletrólitos (hipercalemia grave)	K^+ > 6,0 mEq/L refratário a tratamento clínico
I – Intoxicações	Ex: lítio, metanol, etilenoglicol, salicilato
O – Overload (hipervolemia)	Edema agudo de pulmão ou congestão refratária
U – Uremia	Encefalopatia, pericardite, vômitos refratários

5. PRIORIDADES

- Avaliar **via de acesso dialítico funcional** (fístula, CVC).
- Corrigir **hipercalemia e acidose** imediatamente.
- **Evitar contraste iodado e drogas nefrotóxicas** (AINEs, aminoglicosídeos, IECA/BRAs em instabilidade).
- Tratar **fatores precipitantes** (infecção, hipovolemia, obstrução).
- Avaliar **indicação de TRS** precoce conforme critérios AEIOU.
- Monitorar **glicemia, diurese e sinais de congestão** a cada 2–4h.

Resumo Prático:

Cenário Clínico	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
IRC estável / acompanhamento	Ureia, creatinina, eletrólitos, hemograma, PTH	USG rins e vias urinárias
Descompensação aguda (IRA sobre IRC)	Ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria, PCR	USG abdome total ± RX tórax
Hipercalemia / acidose / dispneia	Gasometria, K^+, lactato, função renal	ECG ± RX tórax
Infecção / sepse em IRC	Hemograma, PCR, culturas, função renal/hepática	RX tórax ± USG abdome
Avaliação pré-diálise	Gasometria, ureia, K^+, HCO_3^-, hemograma	USG abdome total
IRC terminal com sintomas urêmicos	Função renal, lactato, eletrólitos, hemograma	RX tórax ± POCUS cardíaco

Conclusão

O manejo diagnóstico do paciente renal crônico deve ser focado na **identificação precoce de descompensações**, **prevenção de causas reversíveis** e **avaliação rápida de critérios dialíticos**.
O uso racional dos exames reduz sobrecarga, evita contrastes desnecessários e garante segurança clínica.

✅ Avaliação laboratorial dirigida
✅ Diagnóstico rápido de descompensação
✅ Critérios objetivos para TRS
✅ Redução de exames e uso racional de contraste